TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN ĐẠT MỨC 5 – TIÊU CHÍ D2.4

“Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ”

Để đạt **mức 5**, bệnh viện phải chứng minh được:
✅ Có hệ thống quản lý đầy đủ
✅ Nhân viên thực hành đúng thực tế
✅ Có giám sát – đo lường – cải tiến liên tục
✅ Có ứng dụng CNTT hỗ trợ an toàn người bệnh
✅ Người bệnh cùng tham gia xác nhận danh tính

1. HỒ SƠ BẮT BUỘC PHẢI CÓ

Văn bản – SOP

- Quy định xác định người bệnh
- SOP D2.4
- SOP dùng thuốc/lấy mẫu/truyền máu/PTTT

Biểu mẫu

- Checklist xác định NB
- Phiếu audit
- Báo cáo sự cố/suýt sự cố

Quyết định

- Ban hành triển khai toàn viện
- Phân công giám sát

2. THỰC HÀNH THỰC TẾ PHẢI ĐỒNG BỘ

Nhân viên phải:
✅ Hỏi chủ động:
“Anh/chị vui lòng cho biết họ tên và ngày sinh”
✅ Kiểm tra ≥ 2 yếu tố định danh
✅ Thực hiện trước:

- dùng thuốc
- tiêm truyền
- lấy mẫu
- thủ thuật
- truyền máu
- phẫu thuật

❌ Không dùng:

- số giường
- nhìn mặt quen

3. GIÁM SÁT – KPI – AUDIT

Phải có:

- Audit ≥ 12 tháng
- KPI định kỳ
- Dashboard theo dõi
- So sánh khoa phòng

- Kế hoạch khắc phục

KPI nên đạt:

Chỉ số	Mục tiêu
Tuân thủ xác định NB	≥95%
Đeo vòng tay đúng	≥98%
Nhầm NB	=0

4. CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Phải chứng minh:

✅ Có ghi nhận near miss
✅ Có RCA nguyên nhân gốc
✅ Có CAPA cải tiến
✅ Có theo dõi sau cải tiến

5. ỨNG DỤNG CNTT (YẾU TỐ QUAN TRỌNG MỨC 5)

Nên có:

- Vòng tay barcode
- Quét barcode trước dùng thuốc/lấy mẫu
- HIS cảnh báo trùng tên
- Dashboard điện tử
- Bedside scanning

6. TRUYỀN THÔNG & ĐÀO TẠO

Có:

- Đào tạo định kỳ
- Kiểm tra năng lực
- Poster/TV/tờ rơi
- Người bệnh hiểu vì sao bị hỏi nhiều lần

7. MINH CHỨNG "ĂN ĐIỂM" KHI KHẢO SÁT

✅ 100% NB có vòng tay
✅ Checklist dùng thật
✅ Có barcode/scanning
✅ Có dashboard realtime
✅ Có báo cáo suýt sự cố
✅ NVYT thực hành đúng khi đoàn hỏi trực tiếp

8. CÔNG THỨC NGẮN GỌN ĐỂ ĐẠT MỨC 5

Mức 5 =

SOP đầy đủ

-

Thực hành đúng

-

Audit liên tục

-

KPI rõ ràng

-

Có cải tiến

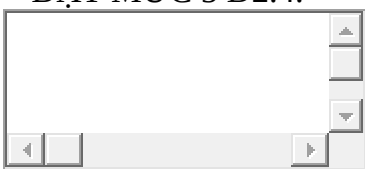
-

Ứng dụng CNTT

-

Người bệnh tham gia an toàn

= ĐẠT MỨC 5 D2.4.



SOP D2.4 – QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH

1. Thông tin chung

Tên quy trình: Quy định xác định người bệnh
Mã số: SOP-D2.4
Phiên bản: 1.0
Ngày ban hành: ……/……/20……
Ngày hiệu lực: ……/……/20……
Khoa/Phòng áp dụng: Toàn bệnh viện
Người soạn thảo: .....
Người xem xét: .....
Người phê duyệt: .....

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Người thực hiện
1.0	……/……/20……	Ban hành lần đầu	

2. Mục đích

Quy định thống nhất việc xác định đúng người bệnh trong mọi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhằm:

- Bảo đảm an toàn người bệnh.
- Ngăn ngừa các sai sót do nhầm lẫn người bệnh.
- Đảm bảo đúng người bệnh – đúng dịch vụ – đúng thuốc – đúng thủ thuật.
- Tuân thủ các quy định của Bộ Y tế và tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện.

---

3. Phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với:

- Toàn bộ người bệnh nội trú, ngoại trú, cấp cứu.
- Tất cả nhân viên y tế tham gia khám, điều trị, chăm sóc và thực hiện dịch vụ kỹ thuật.
- Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng khám và đơn vị liên quan.

4. Tài liệu viện dẫn

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.
- Thông tư số 19/2013/TT-BYT hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.
- Thông tư số 07/2014/TT-BYT về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức ngành y tế.
- Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam hiện hành.
- Quy định an toàn người bệnh của bệnh viện.
- Các quy định chuyên môn hiện hành của Bộ Y tế.

5. Thuật ngữ và định nghĩa

5.1. Xác định người bệnh

Là quá trình kiểm tra và đối chiếu thông tin nhằm bảo đảm người được thực hiện dịch vụ y tế chính là người bệnh cần thực hiện.

5.2. Hai thông tin nhận dạng bắt buộc

Ít nhất phải sử dụng 02 thông tin nhận dạng sau:

- Họ và tên người bệnh.
- Ngày tháng năm sinh.
- Mã số người bệnh/Mã hồ sơ bệnh án.
- Số định danh người bệnh.

5.3. Không sử dụng

- Số giường bệnh.
- Vị trí buồng bệnh.
- Chẩn đoán bệnh.

Làm thông tin nhận dạng duy nhất.

6. Trách nhiệm

Chức danh	Trách nhiệm
Bác sĩ	Xác định đúng người bệnh trước khám, điều trị, thủ thuật
Điều dưỡng/Hộ sinh/KTV	Kiểm tra nhận dạng người bệnh trước mọi can thiệp chăm sóc
Nhân viên lấy mẫu xét nghiệm	Xác nhận người bệnh trước lấy mẫu và dán nhãn mẫu
Khoa Dược	Phối hợp kiểm soát cấp phát thuốc đúng người bệnh
Trưởng khoa/Điều dưỡng trưởng	Giám sát tuân thủ quy định
Phòng Quản lý chất lượng	Kiểm tra, đánh giá và cải tiến quy trình

7. Nội dung quy trình

7.1. Nguyên tắc chung

1. Luôn sử dụng tối thiểu 02 thông tin nhận dạng người bệnh.
2. Người thực hiện phải chủ động hỏi người bệnh hoặc người nhà.
3. Không xác định người bệnh dựa vào vị trí giường bệnh.
4. Mọi hoạt động có nguy cơ cao đều phải xác nhận lại danh tính người bệnh.
5. Người bệnh nội trú phải được đeo vòng nhận dạng theo quy định bệnh viện.

7.2. Các thời điểm bắt buộc xác định người bệnh

- Khi tiếp nhận người bệnh.
- Trước khi dùng thuốc.
- Trước lấy máu hoặc lấy mẫu bệnh phẩm.
- Trước truyền máu và chế phẩm máu.
- Trước thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.
- Trước phẫu thuật, thủ thuật.
- Trước vận chuyển người bệnh.
- Trước thực hiện bất kỳ can thiệp điều trị nào.

7.3. Quy trình thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị

Người thực hiện: Nhân viên y tế

Thực hiện:

- Tiếp cận người bệnh.

- Kiểm tra vòng nhận dạng (nếu có).
- Chuẩn bị hồ sơ hoặc phiếu chỉ định.

Bước 2. Xác định người bệnh

Người thực hiện: Nhân viên y tế

Thực hiện:

1. Yêu cầu người bệnh tự nói:
    - Họ và tên.
    - Ngày tháng năm sinh.
2. Đối chiếu với:
    - Hồ sơ bệnh án.
    - Phiếu chỉ định.
    - Vòng nhận dạng.
3. Kiểm tra ít nhất 02 thông tin nhận dạng.

Bước 3. Xác nhận dịch vụ thực hiện

Người thực hiện: Nhân viên y tế

Thực hiện:

- Đọc lại tên người bệnh.
- Xác nhận dịch vụ sẽ thực hiện.
- Giải thích ngắn gọn cho người bệnh.

Bước 4. Thực hiện dịch vụ

Người thực hiện: Bác sĩ/Điều dưỡng/KTV

Thực hiện:

- Chỉ tiến hành khi thông tin nhận dạng phù hợp.
- Nếu có sai lệch phải dừng ngay và xác minh lại.

Bước 5. Ghi nhận hồ sơ

Người thực hiện: Người thực hiện dịch vụ

Thực hiện:

- Ghi chép vào hồ sơ theo quy định.
- Báo cáo sự cố nếu phát hiện nhầm lẫn hoặc nguy cơ nhầm lẫn.

---

8. Quy định trong các trường hợp đặc biệt

8.1. Người bệnh hôn mê, mất ý thức

Xác định thông qua:

- Vòng nhận dạng.
- Hồ sơ bệnh án.
- Người nhà hợp pháp.
- Thông tin tiếp nhận ban đầu.

8.2. Trẻ sơ sinh

Sử dụng:

- Vòng nhận dạng mẹ và bé.
- Họ tên mẹ.
- Mã số hồ sơ.
- Ngày giờ sinh.

8.3. Người bệnh không giao tiếp được

Xác định thông qua:

- Người giám hộ.
- Hồ sơ bệnh án.
- Vòng nhận dạng.

---

9. Biểu mẫu và hồ sơ liên quan

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu
BM-D2.4-01	Phiếu kiểm tra tuân thủ xác định người bệnh
BM-D2.4-02	Biên bản ghi nhận sự cố nhận dạng người bệnh
BM-D2.4-03	Danh sách kiểm tra an toàn người bệnh trước thủ thuật

10. Kiểm soát rủi ro

Rủi ro	Nguyên nhân	Biện pháp phòng ngừa
Nhầm người bệnh	Không đối chiếu thông tin	Bắt buộc xác nhận 02 định danh
Nhầm mẫu xét nghiệm	Dán nhãn sai	Dán nhãn tại giường bệnh sau lấy mẫu
Nhầm thuốc	Bỏ qua bước xác nhận	Thực hiện nguyên tắc 5 đúng
Nhầm thủ thuật	Không kiểm tra trước thủ thuật	Áp dụng bảng kiểm an toàn

11. Theo dõi – Đánh giá – Cải tiến

Chỉ số theo dõi

1. Tỷ lệ tuân thủ xác định người bệnh ≥ 95%.
2. Tỷ lệ người bệnh có vòng nhận dạng ≥ 98%.
3. Số sự cố nhầm người bệnh.
4. Số lần giám sát tuân thủ theo kế hoạch.

Tần suất đánh giá

- Hàng tháng tại khoa/phòng.
- Hàng quý bởi Phòng Quản lý chất lượng.
- Rà soát và cập nhật SOP tối thiểu 02 năm/lần hoặc khi có quy định mới.

---

12. Phụ lục

Phụ lục 1. Checklist xác định người bệnh

☐ Kiểm tra vòng nhận dạng.
☐ Yêu cầu người bệnh tự khai họ tên.

☐ Yêu cầu người bệnh tự khai ngày sinh.
☐ Đối chiếu hồ sơ bệnh án.
☐ Đối chiếu phiếu chỉ định.
☐ Xác nhận dịch vụ thực hiện.
☐ Thực hiện can thiệp.
☐ Ghi nhận hồ sơ.

Kết thúc SOP D2.4 – Quy định xác định người bệnh.

SOP D2.4A – XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC, LẤY MẪU BỆNH PHẨM, TRUYỀN MÁU VÀ PHẪU THUẬT/THỦ THUẬT (PTTT)

1. Thông tin chung

Tên SOP: Xác định người bệnh trước khi dùng thuốc, lấy mẫu bệnh phẩm, truyền máu và phẫu thuật/thủ thuật
Mã SOP: SOP-D2.4A
Phiên bản: 1.0
Ngày ban hành: ……/……/20……
Ngày hiệu lực: ……/……/20……
Đơn vị áp dụng: Toàn bệnh viện

---

2. Mục đích

Đảm bảo người bệnh được nhận đúng thuốc, đúng mẫu xét nghiệm, đúng máu/chế phẩm máu và đúng phẫu thuật/thủ thuật; phòng ngừa các sự cố y khoa do nhầm lẫn người bệnh.

---

3. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho:

- Bác sĩ.
- Điều dưỡng, hộ sinh.
- Kỹ thuật viên.
- Nhân viên ngân hàng máu.
- Nhân viên thực hiện phẫu thuật, thủ thuật.
- Các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

---

4. Tài liệu viện dẫn

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.
- Thông tư 19/2013/TT-BYT.
- Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.
- Hướng dẫn an toàn người bệnh của Bộ Y tế.
- Quy định truyền máu, phẫu thuật và sử dụng thuốc của bệnh viện.

---

5. Nguyên tắc nhận dạng bắt buộc

Trước mọi can thiệp phải xác nhận tối thiểu **02 thông tin nhận dạng**:

- Họ và tên người bệnh.
- Ngày tháng năm sinh.
- Mã số người bệnh/Hồ sơ bệnh án.
- Mã định danh người bệnh.

Không được sử dụng đơn lẻ:

- Số giường bệnh.
- Tên buồng bệnh.
- Chẩn đoán bệnh.

---

6. Trách nhiệm

Chức danh	Trách nhiệm
Bác sĩ	Xác định đúng người bệnh trước chỉ định và can thiệp
Điều dưỡng/Hộ sinh	Thực hiện xác nhận người bệnh trước dùng thuốc, lấy mẫu, truyền máu
Kỹ thuật viên	Kiểm tra nhận dạng trước thực hiện dịch vụ kỹ thuật
Kíp phẫu thuật/thủ thuật	Thực hiện xác nhận người bệnh theo bảng kiểm an toàn
Điều dưỡng trưởng	Giám sát tuân thủ
Phòng QLCL	Kiểm tra, đánh giá định kỳ

7. Quy trình thực hiện

I. XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC

Bước 1. Kiểm tra hồ sơ

Đối chiếu:

- Phiếu lĩnh thuốc.
- Y lệnh điều trị.
- Hồ sơ bệnh án.

Bước 2. Xác định người bệnh

Yêu cầu người bệnh tự khai:

- Họ tên.
- Ngày sinh.

Đối chiếu với:

- Vòng nhận dạng.
- Hồ sơ bệnh án.
- Phiếu điều trị.

Bước 3. Thực hiện nguyên tắc "5 đúng"

- Đúng người bệnh.
- Đúng thuốc.
- Đúng liều.
- Đúng đường dùng.
- Đúng thời gian.

Bước 4. Dùng thuốc và ghi nhận

- Theo dõi phản ứng.
- Ghi hồ sơ đầy đủ.

II. XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH TRƯỚC KHI LẤY MẪU BỆNH PHẨM

Bước 1. Chuẩn bị

- Phiếu chỉ định xét nghiệm.
- Ống chứa mẫu.
- Nhãn nhận dạng.

Bước 2. Xác định người bệnh

Đối chiếu:

- Họ tên.
- Ngày sinh.
- Mã người bệnh.

Bước 3. Lấy mẫu

- Thực hiện đúng kỹ thuật.
- Hỏi lại người bệnh trước khi lấy mẫu.

Bước 4. Dán nhãn mẫu

Thực hiện ngay tại giường người bệnh hoặc nơi lấy mẫu.

Kiểm tra:

- Họ tên.
- Mã số người bệnh.
- Thời gian lấy mẫu.

Bước 5. Gửi mẫu

- Đối chiếu lần cuối với phiếu xét nghiệm.

III. XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH TRƯỚC KHI TRUYỀN MÁU

Bước 1. Kiểm tra hồ sơ

Đối chiếu:

- Chỉ định truyền máu.
- Phiếu lĩnh máu.
- Kết quả định nhóm máu.

Bước 2. Xác nhận người bệnh

Ít nhất 02 nhân viên y tế cùng kiểm tra:

- Họ tên người bệnh.
- Ngày sinh.
- Mã số người bệnh.

Bước 3. Kiểm tra túi máu

Đối chiếu:

- Tên người bệnh.
- Nhóm máu.
- Mã đơn vị máu.
- Hạn sử dụng.

Bước 4. Truyền máu

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn.
- Theo dõi phản ứng truyền máu.

Bước 5. Hoàn tất

- Ghi hồ sơ truyền máu.
- Báo cáo phản ứng bất lợi (nếu có).

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH TRƯỚC PHẪU THUẬT/THỦ THUẬT

Bước 1. Trước chuyển người bệnh

Kiểm tra:

- Họ tên.
- Ngày sinh.
- Mã hồ sơ.
- Giấy cam kết.

Bước 2. Đánh dấu vị trí phẫu thuật (nếu áp dụng)

Do bác sĩ thực hiện theo quy định bệnh viện.

Bước 3. Time Out (Dừng kiểm tra an toàn)

Thực hiện ngay trước can thiệp.

Toàn bộ ê-kíp xác nhận:

- Đúng người bệnh.

- Đúng thủ thuật/phẫu thuật.
- Đúng vị trí.
- Đúng hồ sơ.
- Đúng phương tiện.

Bước 4. Tiến hành phẫu thuật/thủ thuật

Chỉ thực hiện sau khi hoàn tất xác nhận.

Bước 5. Hoàn tất hồ sơ

- Ghi biên bản thủ thuật/phẫu thuật.
- Lưu bảng kiểm an toàn.

---

8. Kiểm soát rủi ro

Nguy cơ	Biện pháp kiểm soát
Nhầm người bệnh dùng thuốc	Kiểm tra tối thiểu 02 định danh
Nhầm mẫu xét nghiệm	Dán nhãn tại nơi lấy mẫu
Truyền nhầm máu	Kiểm tra chéo bởi 02 nhân viên y tế
Phẫu thuật nhầm người bệnh	Thực hiện Time Out bắt buộc
Phẫu thuật sai vị trí	Đánh dấu vị trí trước phẫu thuật

9. Biểu mẫu liên quan

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu
BM-D2.4A-01	Phiếu kiểm tra nhận dạng người bệnh
BM-D2.4A-02	Phiếu theo dõi truyền máu
BM-D2.4A-03	Bảng kiểm an toàn phẫu thuật
BM-D2.4A-04	Phiếu lấy mẫu xét nghiệm
BM-D2.4A-05	Phiếu giám sát tuân thủ xác định người bệnh

10. Theo dõi và đánh giá

Chỉ số chất lượng

- Tỷ lệ tuân thủ xác định người bệnh trước dùng thuốc ≥ 95%.

- Tỷ lệ tuân thủ xác định người bệnh trước lấy mẫu ≥ 95%.
- Tỷ lệ tuân thủ xác định người bệnh trước truyền máu = 100%.
- Tỷ lệ tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật ≥ 95%.
- Số sự cố nhầm người bệnh = 0.

Tần suất giám sát

- Hàng tháng tại khoa/phòng.
- Hàng quý bởi Phòng Quản lý chất lượng.
- Cập nhật SOP khi có thay đổi quy định chuyên môn hoặc tối thiểu 02 năm/lần.

Phụ lục: Checklist nhanh xác định người bệnh

Nội dung kiểm tra	Có	Không
Kiểm tra vòng nhận dạng	☐	☐
Người bệnh tự khai họ tên	☐	☐
Người bệnh tự khai ngày sinh	☐	☐
Đối chiếu hồ sơ bệnh án	☐	☐
Đối chiếu phiếu chỉ định	☐	☐
Kiểm tra trước thực hiện can thiệp	☐	☐
Ghi nhận hồ sơ đầy đủ	☐	☐

Yêu cầu bắt buộc: Không thực hiện dùng thuốc, lấy mẫu, truyền máu hoặc phẫu thuật/thủ thuật khi chưa hoàn tất xác định người bệnh theo quy định.

---

1. BM-D2.4-01: CHECKLIST XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH

BIỂU MẪU BM-D2.4-01

CHECKLIST XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH

Khoa/Phòng: .....

Ngày thực hiện: ...../...../.....

Người thực hiện: .....

Mã người bệnh: .....

Họ và tên người bệnh: .....

Mục đích thực hiện:
□ Dùng thuốc
□ Lấy mẫu xét nghiệm
□ Truyền máu
□ Phẫu thuật/Thủ thuật
□ Khác: .....

NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Người bệnh có vòng nhận dạng
   □ Có
   □ Không áp dụng
   □ Không
2. Người bệnh tự khai họ tên
   □ Đúng
   □ Không đúng
   □ Không thực hiện được
3. Người bệnh tự khai ngày tháng năm sinh
   □ Đúng
   □ Không đúng
   □ Không thực hiện được
4. Đối chiếu với hồ sơ bệnh án
   □ Phù hợp
   □ Không phù hợp
5. Đối chiếu với phiếu chỉ định/y lệnh
   □ Phù hợp
   □ Không phù hợp

6. Đối chiếu mã người bệnh
   □ Phù hợp
   □ Không phù hợp
7. Đã xác nhận đúng người bệnh trước thực hiện dịch vụ
   □ Có
   □ Không

KẾT LUẬN

□ Đủ điều kiện thực hiện

□ Chưa đủ điều kiện thực hiện

Ghi chú:
.....
.....

Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đề xuất ngưỡng cảnh báo chất lượng

Chỉ số	Mức cảnh báo
Tuân thủ xác định NB trước dùng thuốc	< 95%
Tuân thủ xác định NB trước lấy mẫu	< 95%
Tuân thủ trước truyền máu	< 100%
Tuân thủ trước PTTT	< 95%
Sự cố nhầm người bệnh	≥ 1 vụ
Suýt sự cố nhận dạng	≥ 2 vụ/tháng

KPI báo cáo Phòng Quản lý chất lượng

- Tỷ lệ tuân thủ chung xác định người bệnh ≥ 95%.
- 100% trường hợp truyền máu được xác nhận bởi 02 nhân viên y tế.
- 100% ca phẫu thuật/thủ thuật thực hiện bước "Time Out".
- Tỷ lệ người bệnh nội trú có vòng nhận dạng ≥ 98%.
- Số sự cố nhầm người bệnh mức nghiêm trọng = 0.

Biểu mẫu này có thể sử dụng trực tiếp cho báo cáo tháng, quý và làm minh chứng đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại tiêu chí D2.4 về nhận dạng người bệnh.

Khuyến nghị hồ sơ minh chứng đầy đủ cho tiêu chí D2.4:

1. Quyết định ban hành SOP.
2. SOP D2.4 – Quy định xác định người bệnh.
3. Quyết định phân công giám sát.
4. Kế hoạch giám sát năm.
5. Checklist xác định người bệnh.
6. Phiếu audit tuân thủ.
7. Phiếu báo cáo sự cố/suýt sự cố.
8. Báo cáo KPI tháng/quý.
9. Biên bản họp phân tích nguyên nhân và cải tiến.
10. Hồ sơ đào tạo, tập huấn nhân viên về xác định người bệnh.